



安全管灌的絕對防線：鼻胃管灌食技術與稽核導航

從原理到執行的 18 道標準安全程序

臨床導航：安全灌食的四大基石

“管灌不僅是技術，更是無法自行進食病患的「生命線」。”

萬全準備

對應題號：01-06

正確的認知、人
與環境。



安全守門員

對應題號：07-09

反抽檢查與潤管
的黃金確認。



精準執行

對應題號：10-14

重力物理學與防
氣反折技巧。



善後與防護

對應題號：15-18

防嗆咳姿勢與無
懈可擊的紀錄。



Phase 1: 萬全準備



稽核考點 [題號 01]：能正確說明鼻胃管灌食目的



適用對象

吞嚥困難、意識不清病人。



主要目的

供給「營養」及「藥物」的唯一安全途徑。

執行前的雙軸黃金確認

對人 (Patient-Centric)



[題號 02]：前、後洗手

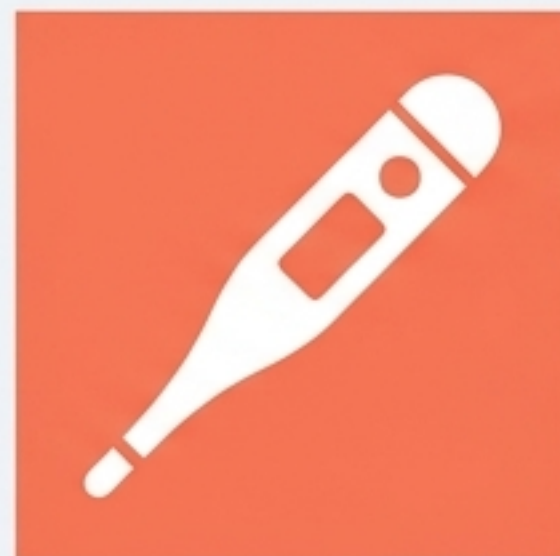


[題號 03]：病人辨識



[題號 04]：病人飲食核對

對物與境 (Environment-Centric)



[題號 05]：
用物準備與食物溫度
37.8–40.5°C



[題號 06]：
坐姿或至少抬高床頭
30 度

Phase 2: 安全守門員 — 灌食前的絕對防線

[題號 07] 正確評估鼻胃管確實在胃內。

反抽檢查決策樹 [題號 08]



以空針反抽檢查胃剩餘物



正常液體 / $< 100\text{cc}$



允許進行本次灌食

未消化食物 $\geq 100\text{cc}$

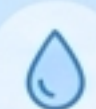


暫停本次灌食



報告護理人員

溫水沖管的雙重目的 (題號 09 vs. 11 比較)



灌食前 (Pre-Flush) [題號 09]



開路

20cc 溫水

目的：確認鼻胃管順暢



灌食後 (Post-Flush) [題號 11]

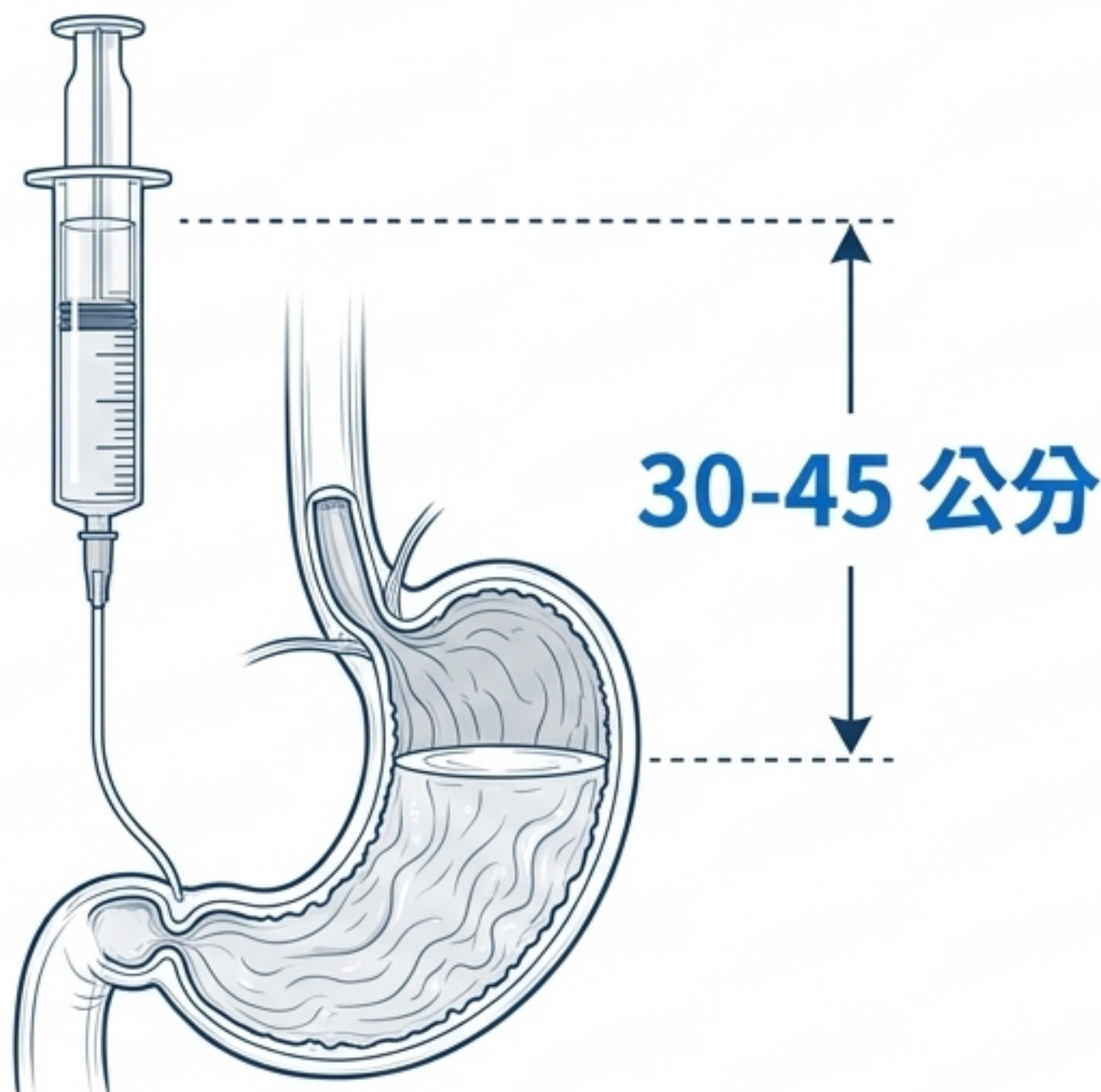


收尾

20-30cc 溫水

目的：清除管內剩餘食物，避免發酵阻塞

Phase 3: 精準執行 — 重力與時間的物理學



[題號 14 關鍵數字]

每次餵食量：250-300cc

餵食時間：不可少於 15-20 分鐘

💡 為什麼是 30-45 公分？太高 = 流速過快導致嘔吐；太低 = 無法克服胃內壓力。理解物理原理，確保精準給藥。

[題號 10] 調整空針高度，使食物緩緩流入

關鍵技術：「反折」的絕對防禦

1. 觀測 (Observe) [題號 14]



當食物液面下降至空針頸部時

2. 阻斷 (Kink) [題號 12]



迅速將鼻胃管反折

3. 封閉 (Seal) [題號 13]



將鼻胃管栓子塞上或保持反折



勿使空氣流入 (防止空氣進入胃部造成嚴重脹氣)

Phase 4: 善後與防護 — 觀察與緊急應變



● 常態防護 [題號 15]



- ✓ 灌食後維持坐姿或至少抬高床頭 30 度
- ✓ 維持時間：20-30 分鐘
- ✓ 絕對禁忌：避免立刻平躺



● 緊急停止 [題號 16]

若發生以下狀況，必須立即停止灌食：



1. 咳嗽



2. 嘔吐



3. 呼吸變化

完美收尾：歸位與無懈可擊的紀錄

[題號 17] 能正確執行用物處理及歸位



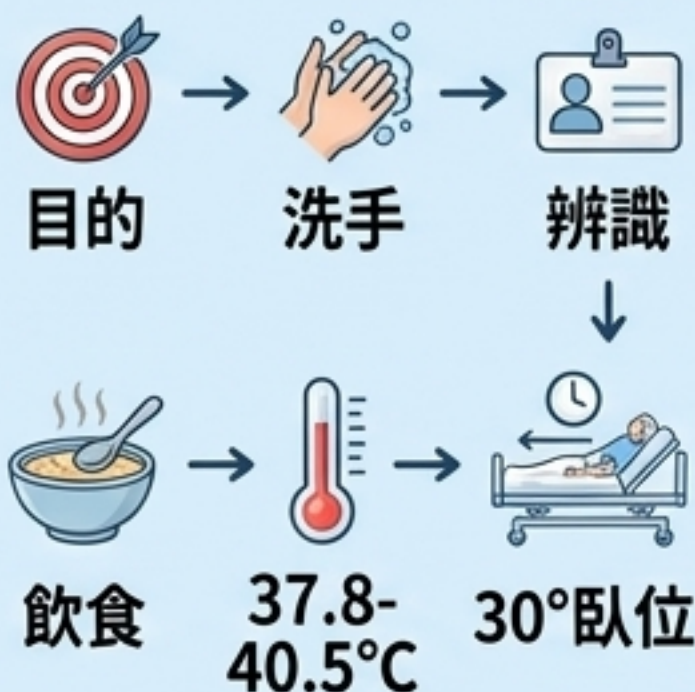
護理紀錄四要素 [題號 18]

- ☒ 灌食時間
- ☒ 反抽胃內容物的存餘量
- ☒ 灌食種類及量
- ☒ 病人反應

⚠ 此四項為考官必定逐一核對的給分點，缺一不可。

單元 11：鼻胃管灌食 — 稽核全覽儀表板

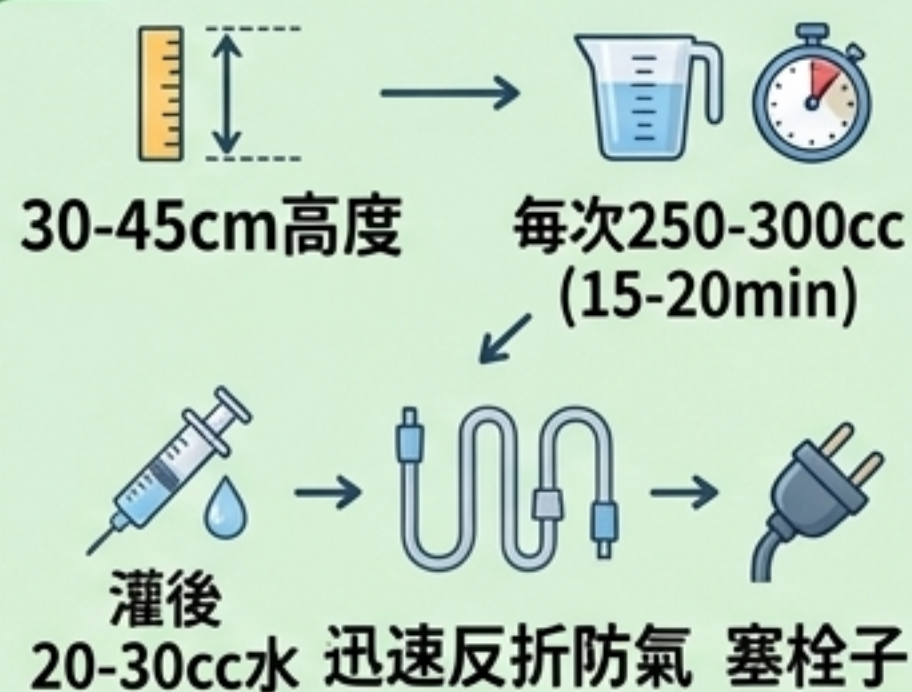
Phase 1 準備 01-06



Phase 2 守門 07-09



Phase 3 執行 10-14



Phase 4 善後 15-18



每一個稽核細節，都是守護病患安全的基石。自信上陣，精準執行！